

Información Paciente

Nombre : Rubén Vargas Delgado
Edad : 76a 4m 4d
Dirección : El Volcan 04523 Villa San Alberto

Rut : 5.863.194-9
Fecha Nacto: 01/11/1949
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A349244
Sexo : Masculino
Teléfono : 941789321

N° Epicrisis
470110

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 24/12/2025 20:48

Días Estadía: 71

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 05/03/2026 16:30

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Fiebre

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Ruben Vargas Delgado
Rut: 5863194-9
Edad: 76a
Previsión: Fonasa B
FI SU: 24/12/2025
FI UTIM 1: 29/12/2025
FI UCI: 02/01/2026
FI UTIM: 25/01/2026
FI SALA: 07/02/26

Anamnesis Remota

- Mórbidos: DM2 IR, Hipoacusia, HTA, IAM en 2012
- Quirúrgicos: Apendicectomía
- Fármacos: Insulina NPH 20-10 UI. Familiar refiere Valsartan, Carvedilol, Aspirina, Amlodipino; no sabe dosis.
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: (-)
- Social: autovalente, trabaja como conductor de taxi.

Historia de Ingreso

Paciente con historia de una semana de evolución de cefalea holocránea con cervicalgia derecha y vértigo, asociado a episodios de emesis. Se agregan 4 días de fiebre hasta 38.5°C y compromiso de conciencia cualitativo, por lo que consultaron en SAPU donde se diagnostica rinofaringitis y se da manejo sintomático. Por persistencia de síntomas acuden a servicio de urgencias CASR.

A su ingreso en regulares condiciones, hipertenso (169/85), taquicárdico hasta 124, febril hasta 37.5°C y sin requerimientos de oxígeno, pero con saturación límite (90%). Al examen físico levemente deshidratado, sudoroso, bien perfundido, inatento, sin nistagmus, fuerzas conservadas, no logra marcha independiente.

Se realiza AngioTAC de cerebro y cuello, sin informe en sistema, pero descrito en ficha que se conversó con radiólogo de turno y se aprecia aire en región facetaria C3 derecha y se recomienda complementar con RM de cerebro. Se realiza TAC TAP que informa aumento de tamaño prostático, y signos sugerentes de DHC, TAC de columna total sin informe

Fecha Epicrisis : 05/03/2026 16:56

Fecha Última Actualización: 05-03-2026 16:56:02

Página 2 de 5

Exámenes de ingreso con hiperbilirrubinemia 1.55, FA 459, GGT 448, LDH 569, glicemia en 368, sin alteraciones electrolíticas, falla renal con crea 1.2 y BUN 23, leucocitosis en 16610, PCR 29 .

Por sospecha de espondilosis, se solicitan HCs I y II (+) a las 9 horas para E. coli MS, se solicita UC que resulta (+) para mismo agente.

Se inició esquema empírico con meropenem + vancomicina sin ajuste posterior a obtener microbiología. Se solicita evaluación por infectología.

Evaluable por traumatología, con sospecha de artritis séptica de articulación facetaria en columna cervical, sin posibilidad de evaluar existencia o extensión de absceso dado falta de RM, se solicita RM de columna cervical y reevaluación con imágenes con IC.

Además, durante estadía en servicio de urgencias con hiperglicemia sin criterios de CAD/SHH, en manejo con insulina correccional.

Evoluciona con lento descenso de parámetros inflamatorios, algunos episodios de agitación que requirió por un día BIC de ketamina.

Diagnósticos de ingreso

Bacteriemia por E coli MS

- Foco urinario

- obs Artritis séptica de articulación facetaria C3

Delirium hiperactivo

AKI KDIGO I obs prerenal

Hiperglicemia no CAD/SHH

Evolución por sistemas

- Hemodinamia: hipertenso desde ingreso con uso de vasodilatadores habituales. Sin conflicto perfusional, impresiona seco, quedando con aporte de agua libre EV por hipernatremia. 02/01 presenta compromiso de conciencia asociado a hipernatremia en 166, requiere inicio de NAd hasta 0.22 por lo que se traslada a UPC donde es intubado. Evoluciona de forma tórpida pero favorable, logrando suspensión el 06/01. 07/01 presenta sangrado de 2 L aprox, con shock hemorrágico 2ro, requiriendo reinicio de NAd a 0.6, vasopresinas 0.04 y 4UGR+4PFC, titulando DVA rápidamente a la baja. 08/01 Tf 1UGR. 9/01 1UGR + 8 crioprecipitados. 09/01 se suspende vasopresina, quedando solo con NAd, se tf 2ugr. 11/01 suspende DVA, evolucionando con HTA. 19/01 se reinician BB. Posteriormente estable, menos hipertenso, por lo que se ajustan antihipertensivos orales con excelente manejo de presiones.

- Respiratorio: Estable, sin conflicto respiratorio inicialmente. En contexto de compromiso de conciencia, con VMI del 02/01 al 16/01/26, sin nuevo control imageneológico con múltiples cultivos de vía aérea (+). Se decide TQT percutánea el 15/01 en contexto de weaning prolongado. Mal progreso en rehabilitación, impresiona debido a estado de conciencia, no tolerar VF, por lo que evoluciona con lenta progresión. Finalmente el 26/02 es decanulado, sin incidentes.

- Infeccioso: Ingresa por sepsis de foco urinario y bacteriemia por E. coli MS, con TC TAP de ingreso (25/12/25) muestra signos de artritis séptica en región facetaria de C3, se inicia manejo con ceftriaxona en dosis meníngeas en plan de completar 6 semanas, sin posibilidad de estudio de LCR por sospecha de absceso asociado (2 semanas de demora para RNM con anestesia), este último confirmado con RM de columna, sin indicación de manejo quirúrgico por TMT. Durante hospitalización con múltiples hits infecciosos, destaca último control con TC de 26/12, solo con seguimiento de columna con TC/RM que muestra persistencia de signos de artritis séptica en C3 con absceso de 1 cm.

Al traslado a UTIM con CAZ/AVI (desde el 23/01) en contexto de CAET (+) KPN BLEE KPC. Parámetros inflamatorios elevados y estacionarios, febril al traslado, con nuevos cultivos, aún pendiente TC TAP y RM columna y cerebro. Últimos cultivos efectivos (tiene unos del 30/01 rechazados), del 26/01 (+) 1 de 2 a las 16 h para S hamolitycus R cloxa S Vanco, sospecha de contaminación. Evaluado por infecto, inicialmente se sugiere manejo con ceftriaxona + vancomicina, ceftriaxona en plan de completar hasta el 10/02, vancomicina suspendida por Niveles plasmáticos supratrapéuticos, último control en rango, sin indicación de mantener, dudosa bacteriemia ya estaría tratada. Sin nuevos peak febriles, Parámetros inflamatorios a la baja. Posteriormente se mantiene solo con Ceftriaxona que es suspendida el 17/02 luego (7 semanas) por retraso en RNM con anestesia. Desde ese momento sin nueva intercurencia infecciosa, de alta infectológica.

- Neurología: Evaluado por especialidad, con compromiso de conciencia con hipernatremia severa que requirió IOT. Dado severidad de la agitación, se toma EEG que resulta sin patrón de crisis, con lentitud intermitente anterior bilateral, disfunción lenta continua generalizada, con signos de impregnación farmacológica. Última RM del 08/01/26. Se solicita nueva RM de cerebro que se realiza el 16/02, sin alteraciones mayores. Dado esto, sin hallazgos que sugieran enfermedad distinta de

Fecha Epicrisis : 05/03/2026 16:56

Página 2 de 5

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:03

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 05-03-2026 16:56:02

Página 3 de 5

delirium, se mantiene con manejo del mismo, con lenta mejoría, con apoyo de antipsicóticos horario + SOS. El 01/03 sufre caída a nivel al intentar ir al baño (sin delirio en ese momento). TAC del 03/03 sin alteraciones hemorrágicas agudas, sin indicación Neuroqx (conversado con neurocirujano de turno).

- Gastro: Presento alteración de Pruebas hepáticas con patrón colestásico con descenso espontáneo. Durante estadía en UPC hemorragia digestiva (06/01). EDA 08/01: Úlcera duodenal grande FIB (40 % del diámetro)+ Inyectoterapia. Gran coágulo gástrico + duodenal. EDA 09/01: Úlcera cuerpo FIIA Clip + Inyectoterapia. Úlcera duodenal F III. Se mantiene con IBP. Sin nuevos episodios de sangrado, Hb estable.

- Traumatológico: Artritis séptica en región fascetaria C3, con absceso interfascetario C3-C4 de 10 mm. Evaluado previamente por equipo, con indicación de manejo médico. Se solicita nuevamente estudio con RM de columna, luego de completado tto, donde se observa desaparición de absceso y Ausencia de signos de artritis. Es dado de alta por equipo TMT. Nunca tuvo compromiso neurológico ni requirió intervención.

- Metabólico: Antecedente de DM2 IR con regular control, sin CAD ni SHH. Se reinicia esquema basal + correccional, y desde el 13/01 se inicia Nutrición enteral (luego de suspensión NAD). HbA1c de 5.9, con buen manejo de glicemias con esquema en baja continua y escaso requerimiento correccional.

- Nefrológico: Con Ascenso de Creatinina en contexto sepsis, sin requerir TRR, con mejoría progresiva. Posteriormente con ascenso de creatinina desde 0.5 a 1.9, asociado a niveles supratrapéuticos de Vancomicina, en recuperación luego de suspender fármacos Nefrotóxicos. En ese contexto además con Acidosis metabólica transitoria recuperada. Posteriormente sin conflicto, estabiliza Creat en 1 (se interpreta como ERC dado nivel de sarcopenia).

- Urológico: HPB sin uso sonda Foley previa, con ant de prostatitis. Se mantiene con CUP durante casi toda la estadía. Se reinicia tto. crónico hace 2 semanas. Se intenta retiro el 04/03 sin éxito, por lo que se va con sonda foley para su domicilio + IC Uro para seguimiento y eventual cirugía.

- Rehabilitación/ Geriátrico: por compromiso de conciencia persistente, fluctuante, caracterizado por inatención y desorientación T-E con lenta rehabilitación. Desde el 16/01 con traqueotomía que finalmente es retirada el 16/02, y con régimen 0 por boca por azul metileno (+) con SNG y alimentación enteral ajustada a requerimientos diabéticos, que finalmente es retirada el 04/03. En cuanto a la rehabilitación motora con importante sarcopenia y complicaciones de la dismovilidad (LPP G II, que cierra en la medida que aumenta movilidad); por lo que requiere continúe rehabilitación en domicilio de ambas profesiones.

LABORATORIO

04/03: Ca 8.9, Creat 1.08, BUN 41, P 3.6, PCR 5, ELP 139/4.07/101, Hb 10.4, GB 6300, PLQ 350

MICROBIOLOGÍA

24/12: HC + UC (+) E.coli MS

06/01: CAET (+) E. coli BLEE KPC + KPN BLEE

12/01: CAET (+) KPN BLEE KPC

21/01: CAET (+) KPN BLEE KPC--HC Perifericos (-) PUNTA CVC/PICCLINE (+) E. faecium

26/01: HC I (+) S. haemolyticus 16 hrs. HC II (P) + Punta CVC (S. epidermidis) + UC (c albicans)

ECGcardiograma TT (09/01): 1. Ventrículo izquierdo cavidad pequeña hiperdinámico, levemente hipertrófico. Función sistólica global y segmentaria normal. Se observa aceleración de flujo a nivel del TSVI con aumento gradientes en reposo hasta 45 mmHg.

2. Aurícula izquierda de dimensión normal.

3. Válvulas aórtica y mitral normofuncionales, sin alteraciones significativas.

4. Cavidades derechas de tamaño normal, con índice de función sistólica normal. Sin vegetaciones. FEVI 71%

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

Comp. conciencia multifactorial de difícil manejo, fluctuante.

Delirium

Paciente crítico crónico en rehabilitación

- VMI 02/01 al + 16/01/26 con TQT percutánea (15/01/26). Decanulado 27/02.

- Miopatía del paciente crítico.

Fecha Epicrisis : 05/03/2026 16:56

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 05-03-2026 16:56:02

Página 4 de 5

- Trast. deglutorio en rehabilitación
ERC etapa IIIa en seguimiento
Shock Séptico Tratado
- Foco Urinario-bacteriémico por E coli MS (24/12/25) Tratada
- Artritis Séptica Interfacetaria C2-C3 Derecha + Colección 10 mm (RM 08.01.26) tratada
- Resueltos: Respiratorio Obs. NIH vs Traqueobronquitis CAET (+) KPN BLEE KPC (06/01/26) Tratada. Bacteriemia S. haemolyticus Tratada.
Shock Hemorrágico Tratado
- EDA 08/01: Úlcera duodenal FIIb, inyectoterapia - EDA 09/01: Úlcera de cuerpo (FIIa), clip + inyectoterapia. Úlcera duodenal (FIII).
Antecedentes: DM2 IR, Hipoacusia, HTA, IAM en 2012, HPB, hizo prostatitis por E. Coli (2023)

Diagnóstico de Egreso

Infección Bacteriana De Sitio No Especificado -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

bien estable.
Con Sonda foley

Plan Post Alta

INDICACIONES

Reposo Relativo Asistido + Uso de ayuda técnica (retirar en CESFAM correspondiente)
Papilla + líquidos claros con bombilla + pan de molde con queso. Agua libre a demanda.
Seguimiento con Fonoaudiología + Kinesioterapia EN HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

MEDICAMENTOS

Tamsulosina/Dutasteride 0.4/0.5, 1 comp/día VO molido
Losartan 50 mg cada 24 hrs VO molido
Quetiapina 100 mg PM por VO molido
Omeprazol 20 mg/día VO
Lactulosa 20 cc 12 hrs por VO SOS si no tiene deposiciones
Insulina NPH: 10 UI AM - 8 UI PM subcutáneo

Paracetamol 1 g cada 8 hrs SOS si dolor o fiebre VO

CONTROLES

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA: Objetivo de rehabilitación, principalmente en lo motor y en lo fonoaudiológico. Sin ATB ni medicamentos EV.
Seguimiento por EU para cuidados sonda foley
Control con Traumatología (entregó IC) sin prioridad para seguimiento.
Control con Urología (Entregó IC) prioritario dado que HPB fue causa descompensante, y se va con sonda foley.
Control con CESFAM correspondiente para evaluar posibilidad de ingreso programa dependientes y entrega de fármacos.
Control con morbilidad para seguimiento clínico por médico CESFAM. Ev aluar delirium y ajuste farmacos.
Re-ingreso programa Cardiovascular CESFAM correspondiente, para seguimiento diabetes.
Control SOS Servicio urgencias si fiebre o dolor intenso

Indicaciones

Tipo de Reposo : Asistido

Régimen Alimentario : En Pauta Fono/Nutri

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 05/03/2026 16:56

Página 4 de 5



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 05-03-2026 16:56:02

Página 5 de 5

Carolina Ramirez Arzola

INTERNO

Becado/Residente

Juan Carlos Claro Garcia-Atance

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 05/03/2026 16:56

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:03

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar